

Épistaxis et troubles de l'hémostase approche intégrée

Merzougui Z

Service d'ORL, EPH de Batna

Introduction : L'épistaxis est une urgence fréquente en ORL. Sa prise en charge devient complexe chez les patients sous anticoagulants, antiagrégants plaquettaires ou présentant une maladie hémorragique. L'objectif de cette étude était d'identifier les facteurs prédictifs de gravité et d'évaluer les stratégies thérapeutiques chez ces patients au niveau de service d'Orl de l'EPH de Batna.

Matériels et méthodes : une étude rétrospective descriptive dans le service d'ORL de l'EPH de Batna, sur une période de trois ans, de janvier 2023 à décembre 2025. Ont été inclus les patients pris en charge pour une épistaxis nécessitant une intervention médicale, une hospitalisation ou un geste d'hémostase, présentant un traitement anticoagulant/antiagrégant ou une maladie hémorragique connue ou découverte lors du bilan.

Résultats : 32 patients ont été inclus, avec un âge moyen de 35 ans. Les principaux facteurs de risque identifiés étaient l'âge avancé, la prise d'anticoagulants, les anomalies du bilan de coagulation et les antécédents d'épistaxis récidivantes. Les formes sévères étaient principalement associées aux saignements postérieurs, aux troubles biologiques de l'hémostase et à la nécessité d'un tamponnement postérieur ou d'un geste interventionnel. La prise en charge reposait sur une stratégie combinée associant mesures locales, correction des anomalies de l'hémostase en collaboration avec l'hématologie et adaptation des traitements antithrombotiques selon le risque thrombotique individuel. Le contrôle du saignement a été obtenu chez la majorité des patients.

Discussion: Nos résultats sont globalement concordants avec ceux rapportés dans la littérature. **Zachary et al.** ont identifié l'âge avancé, l'HTA et les traitements antithrombotiques comme facteurs associés à une évolution plus sévère. **Hughes et al.** ont également retrouvé une association entre certains troubles hémorragiques et la sévérité de l'épistaxis. **Bahloul et al.** soulignent que les anticoagulants sont surtout associés aux récurrences, tandis que les épistaxis postérieures sont davantage liées aux formes nécessitant une intervention. **Escabasse et al.** recommandent une adaptation individualisée des traitements antithrombotiques selon le risque hémorragique et thrombotique

Conclusion : Les épistaxis chez les patients à risque hémorragique nécessitent une évaluation précoce et une prise en charge personnalisée. L'identification des facteurs prédictifs de gravité et l'approche multidisciplinaire ORL–hématologie–anesthésie permettent d'optimiser le contrôle du saignement et de réduire les complications.